

薬物療法：各論2 原発不明がん、希少がん、副作用対策、高齢者のがん診療

●原発不明がん

- ・診察、検査を行っても原発巣が特定できない固形がん、一般には予後不良。
- ・全悪性腫瘍の3-5%と考えられている。
- ・約20%ほど存在する特定の治療を施しうるサブグループを見逃さないこと→このサブグループは比較的予後良好。

●胚細胞腫瘍

- ・希少がんのうち、予後良好（治癒が目指せる）な腫瘍として取り上げる。
- ・**青壮年に好発**し、進行が早い、進行期でも根治が望める。
- ・胎生期の多分化能をもつ原始胚細胞が腫瘍化したもの。
- ・生殖器（精巣、卵巣）と体中心線にあたる部位（縦隔、後腹膜、仙骨部、松果体、神経下垂体部など）に好発。
- ・診断、病期診断、治療効果判定として**AFP、 β -hCG**を用いる。

○治療

- ・治療は原発巣の組織型などからセミノーマと非セミノーマに分類。
- ・進行性セミノーマおよび進行性非セミノーマは高位精巣摘除術後に化学療法。
- ・BEP療法（ブレオマイシン、エトポシド、シスプラチン）
- ・胚細胞腫瘍は若年者に多く、長期生存が得られる。（治癒が期待できる。）
→晩期毒性（不妊、2次発癌、心血管毒性）

●抗がん化学療法の副作用について

- ・骨髓細胞、口腔・消化管粘膜上皮細胞など増殖が盛んな細胞ほど抗がん剤の感受性は高い。
- 骨髓抑制、口内炎、下痢**などは急性毒性として早期に対応する。

○血液毒性/非血液毒性

●白血球減少（好中球減少）

- ・多くの抗がん剤に共通する副作用で、多くは投与後7-14日で最低値。
- ・発熱性好中球減少症はときに生命に関わる。感染症の危険があれば**顆粒球コロニー刺激因子**を投与。

●貧血、血小板減少

- ・赤血球の寿命は約120日と長く、貧血は緩徐に発現する→赤血球濃厚液輸血を行う。

●悪心・嘔吐

- ・リスク分類に応じて**抗セロトン拮抗薬、ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬**、**制吐薬**を用いる。抗不安薬の適応も。

●口内炎・消化管粘膜炎

- ・解熱鎮痛薬、感染コントロール、栄養管理など

●下痢

- ・抗悪性腫瘍薬による下痢は、脱水、腎機能障害、電解質異常、敗血症を伴う。
- ・感染や炎症の管理、軽度なら止痢剤（ロペラマイド）内服、重症は補液、予防的抗菌薬、オクトレオチドなど
- ・免疫チェックポイント阻害薬の下痢は免疫関連有害事象→ステロイドも考慮。

●肺障害

- ・腹部CTの確認、被疑薬を中止
- ・ステロイドパルス

●脱毛・神経障害

- ・脱毛は一過性で、刺激の少ないシャンプーや石鹸を使用。**ステロイドはX**。
- ・末梢神経障害：可逆性に乏しいので、早期発見、休薬が必要。